BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHẬT TÂN

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

QUY TRÌNH SỬ DỤNG THUỐC TẠI KHOA LÂM SÀNG

QT số 01
Bản hoàn thiện từ tài liệu năm 2025
Cập nhật ngày 13/10/2026

Bản trình thẩm định và phê duyệt. Ngày ban hành, phiên bản áp dụng và chữ ký được bổ sung theo quyết định của bệnh viện.

Thông tin kiểm soát	Nội dung
Mã số tài liệu	QT số 01 theo bản nguồn; mã quản lý chính thức: .....
Lần ban hành / phiên bản	.....
Ngày ban hành / ngày hiệu lực	.....
Quyết định ban hành	.....
Đơn vị quản lý	Phòng Điều dưỡng; phối hợp Khoa Dược

Thông tin nhân sự dưới đây được giữ từ bản nguồn để bệnh viện xác nhận, không xác nhận việc phê duyệt bản cập nhật.

Vai trò	Họ và tên theo bản nguồn	Chức danh theo bản nguồn	Chữ ký
Người soạn thảo	Võ Hồng Thái	Trưởng phòng Điều dưỡng	
Người kiểm tra	Nguyễn Hùng Tâm	Trưởng phòng KHTH	
Người phê duyệt	Châu Hữu Hầu	Giám đốc bệnh viện	

I MỤC ĐÍCH

Thống nhất việc tiếp nhận, chuẩn bị, thực hiện, theo dõi và quản lý thuốc tại khoa lâm sàng; bảo đảm an toàn người bệnh, phòng ngừa sai sót và đạt mục tiêu điều trị theo chỉ định.

II PHẠM VI ÁP DỤNG

Áp dụng cho điều dưỡng, hộ sinh và các nhân viên được phân công thực hiện dùng thuốc tại khoa lâm sàng Bệnh viện Đa khoa Nhật Tân, trong phạm vi hành nghề và năng lực được xác nhận. Bác sĩ, Khoa Dược và các bộ phận liên quan phối hợp theo trách nhiệm chuyên môn.

Quy trình này quy định công tác sử dụng thuốc chung; thao tác từng đường dùng, thuốc đặc thù và xử trí cấp cứu thực hiện theo quy trình kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng chế phẩm và phác đồ đã được bệnh viện phê duyệt.

III TÀI LIỆU VIỆN DẪN

1. Thông tư 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện.
Nguồn: https://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=152956

2. Thông tư 23/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 hướng dẫn sử dụng thuốc trong các cơ sở y tế có giường bệnh; đối chiếu nội dung sửa đổi và bản hợp nhất 07/VBHN-BYT ngày 19/4/2018.
Nguồn: https://congbao.chinhphu.vn/van-ban/thong-tu-so-23-2011-tt-byt-11566.htm

3. Thông tư 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ.
Nguồn: https://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=128248

4. Thông tư 18/2026/TT-BYT ngày 01/6/2026 quy định chi tiết một số điều của Luật Dược và Nghị định 163/2025/NĐ-CP về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt; có hiệu lực từ 16/7/2026.
Nguồn: https://congbao.chinhphu.vn/van-ban/thong-tu-so-18-2026-tt-byt-469674.htm

5. WHO Patient Safety Solutions – Patient Identification, 2007; tham khảo nhận diện người bệnh.
Nguồn: https://www.who.int/docs/default-source/integrated-health-services-%28ihs%29/psf/patient-safety-solutions/ps-solution2-patient-identification.pdf

6. WHO Medication safety for look-alike, sound-alike medicines; tham khảo phòng ngừa nhầm thuốc.
Nguồn: https://www.who.int/publications/b/65628

Tài liệu nội bộ áp dụng kèm theo: danh mục thuốc tủ trực; danh mục thuốc nguy cơ cao và LASA; quy trình nhận diện người bệnh, phản vệ, báo cáo sự cố và ADR; hướng dẫn quản lý thuốc phải kiểm soát đặc biệt; quy trình kỹ thuật dùng thuốc theo

từng đường dùng. Bệnh viện bổ sung mã số và phiên bản các tài liệu trước ban hành.

IV THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT

Sai sót dùng thuốc là sai sót có thể phòng tránh trong quá trình liên quan đến dùng thuốc; cần ghi nhận cả sự cố chưa đến người bệnh. Phản ứng có hại của thuốc (ADR) và sai sót dùng thuốc được báo cáo theo biểu mẫu và đầu mối tương ứng, kể cả khi chưa xác định đầy đủ nguyên nhân.

BS: bác sĩ; BSĐT: bác sĩ điều trị; BSTK: bác sĩ trưởng khoa; ĐD: điều dưỡng; HS: hộ sinh; ĐDT: điều dưỡng trưởng; NB: người bệnh; KHTH: Kế hoạch tổng hợp; QLCL: Quản lý chất lượng; ADR: phản ứng có hại của thuốc; LASA: thuốc có tên đọc/viết hoặc hình thức dễ nhầm lẫn; FEFO: hết hạn trước, xuất trước; FIFO: nhập trước, xuất trước.

V NỘI DUNG QUY TRÌNH

5.1. Trình tự thực hiện

Bước	Người thực hiện	Nội dung chính và kết quả cần có
1. Trước dùng thuốc	ĐD/HS; BSĐT và Khoa Dược khi cần	Kiểm tra y lệnh; nhận diện bằng ít nhất hai thông tin; kiểm tra dị ứng, thuốc, liều, đường dùng, thời điểm và khả năng dùng thuốc. Giải thích, công khai thuốc; chuẩn bị phương tiện phù hợp. Làm rõ mọi bất thường trước thực hiện.
2. Trong dùng thuốc	Nhân viên được phân công	Đối chiếu tại người bệnh; thực hiện 5 đúng và kỹ thuật của đường dùng; kiểm tra nhãn, nồng độ, tương hợp, tốc độ khi có. Theo dõi đáp ứng và bất thường; không để thuốc chưa nhận diện hoặc tự đổi y lệnh.
3. Sau dùng thuốc	Nhân viên thực hiện	Ghi nhận ngay sau thực hiện; theo dõi hiệu quả và phản ứng; ghi rõ thuốc chưa dùng hoặc người bệnh từ chối và báo bác sĩ. Thu gom, vệ sinh dụng cụ, bàn giao kế hoạch theo dõi.
4. Khi có bất thường hoặc sai sót	Nhân viên phát hiện; BSĐT/BS trực	Đánh giá người bệnh, dừng thao tác sai đang diễn ra, gọi bác sĩ/hỗ trợ cấp cứu ngay. Thực hiện chỉ định xử trí; đồng thời thông báo ĐDT, Khoa Dược và đầu mối sự cố. Lưu thông tin, báo cáo và theo dõi.
5. Quản lý tại khoa	ĐD được phân công; ĐDT; Khoa Dược	Kiểm tra khi nhận, bảo quản đúng điều kiện, kiểm kê và bàn giao; quản lý thuốc phải kiểm soát đặc biệt; trả thuốc dư, cách ly thuốc hỏng/thu hồi và xử lý chênh lệch theo quy định.

5.2. Quy định cụ thể

5.2.1. Dùng thuốc cho người bệnh cần lưu ý một số điều như sau:

5.2.1.1. Khi thực hiện dùng thuốc người bệnh:

- Tác phong làm việc phải chính xác, khoa học và có trách nhiệm.

- Thực hiện đúng y lệnh hợp lệ. Khi có nghi ngờ, thiếu thông tin hoặc bất thường, chưa thực hiện liều thuốc đó và liên hệ bác sĩ để làm rõ; phối hợp dược sĩ khi cần.

- Không tự thay đổi thuốc, liều, đường dùng, tốc độ hoặc thời điểm. Y lệnh thay đổi phải được xác nhận và cập nhật hồ sơ; tình huống cấp cứu thực hiện theo quy định y lệnh cấp cứu của bệnh viện.

5.2.1.2. Sắp xếp, bảo quản và sử dụng thuốc:

- Ưu tiên FEFO; sử dụng FIFO khi phù hợp giữa các lô cùng hạn dùng. Duy trì nhãn và truy xuất lô, không dùng thuốc hết hạn.

- Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: phân loại, bảo quản, quản lý quyền tiếp cận, sổ sách, kiểm kê, bàn giao và hoàn trả theo quy định hiện hành và hướng dẫn Khoa Dược.

- Thuốc độc và các thuốc cần quản lý riêng được nhận diện, bố trí tách biệt theo danh mục hiện hành; không sử dụng cách phân loại thuốc độc A, B trong bản cập nhật này.

- Các thuốc có điều kiện bảo quản đặc biệt phải đảm bảo bảo quản đúng theo điều kiện mà nhà sản xuất yêu cầu.

- Áp dụng danh mục LASA của bệnh viện: bố trí, nhãn cảnh báo và đối chiếu tên, nồng độ/hàm lượng; không nhận diện thuốc chỉ bằng màu sắc hoặc vị trí lưu trữ.

- Thuốc dùng ngoài da để xa thuốc uống.

- Kiểm tra thuốc hàng ngày. Cách ly thuốc hỏng, hết hạn, nghi kém chất lượng hoặc có thông báo thu hồi, không sử dụng; báo Khoa Dược để xử lý. Thuốc cận hạn được điều phối theo FEFO và quy định bệnh viện, không coi là thuốc hỏng.

- Kiểm kê bàn giao thuốc cẩn thận sau mỗi ca làm việc.

5.2.2. Nguyên tắc chung khi cho người bệnh dùng thuốc:

5.2.2.1. Trước khi người bệnh dùng thuốc:

- Xác định đúng NB bằng ít nhất hai thông tin, ví dụ họ tên và ngày sinh hoặc mã NB; đối chiếu với hồ sơ/vòng nhận diện. Số giường, số buồng không được dùng làm thông tin định danh. NB không giao tiếp được thực hiện theo quy trình nhận diện của bệnh viện.

- Kiểm tra y lệnh.

- Công khai thuốc dùng hàng ngày cho người bệnh.

- Giải thích để NB tuân thủ; kiểm tra tiền sử và thông tin dị ứng đã ghi nhận trước mỗi lần dùng, làm rõ dị ứng mới hoặc thay đổi. Đánh giá khả năng nuốt, đường dùng và các thông số cần kiểm tra theo từng thuốc.

- Kiểm tra thuốc:

+ Tên thuốc, nồng độ, hàm lượng, liều dùng một lần, số lần dùng thuốc trong 24 giờ, khoảng cách giữa các lần dùng thuốc, thời điểm dùng thuốc và đường dùng thuốc so với y lệnh.

+ Kiểm tra hạn sử dụng và chất lượng cảm quan của thuốc. Khi phát hiện những bất thường trong y lệnh như chỉ định sử dụng thuốc quá liều quy định, đường dùng không hợp lý hoặc dùng nhiều thuốc đồng thời gây tương tác, điều dưỡng viên phải báo cáo ngay với bác sĩ điều trị hoặc bác sĩ trực.

- Chuẩn bị phương tiện và thuốc:

+ Chuẩn bị đủ phương tiện cho người bệnh dùng thuốc, nếu thuốc uống phải có: khay thuốc, nước uống hợp vệ sinh, dụng cụ đựng thuốc uống cho từng người bệnh.

+ Phương tiện vận chuyển thuốc phải đảm bảo sạch sẽ, sắp xếp gọn gàng, dễ thấy.

+ Chuẩn bị sẵn sàng hộp thuốc cấp cứu và sơ đồ chi tiết về chẩn đoán và xử trí phản vệ.

- Thuốc tiêm/truyền được pha đúng dung môi, nồng độ, thể tích, độ ổn định và tương hợp theo hướng dẫn chế phẩm. Ghi nhãn thuốc sau pha với thông tin nhận diện NB, tên thuốc, liều/nồng độ, dung môi, thời điểm pha và thông tin sử dụng theo quy định; không dùng bơm tiêm hoặc dịch đã pha không nhận diện được.

- Thuốc nguy cơ cao: thực hiện kiểm tra độc lập khi danh mục và quy trình bệnh viện yêu cầu; kiểm tra tính toán liều, nồng độ, cài đặt bơm truyền và đường truyền theo thuốc. Không đưa một thông số hoặc tốc độ chung cho mọi chế phẩm.

5.2.2.2. Trong khi dùng thuốc cho người bệnh, điều dưỡng viên, hộ sinh viên phải:

- Phải tập trung tư tưởng cho việc dùng thuốc, sao chép y lệnh phải thật chính xác tránh nhầm lẫn, dùng thuốc đúng theo chỉ định của bác sĩ điều trị.

- Thực hiện 5 đúng: đúng NB, đúng thuốc, đúng liều, đúng đường dùng, đúng thời gian. Đối chiếu y lệnh và nhãn khi lấy thuốc, chuẩn bị thuốc và ngay trước dùng tại NB. Quy tắc 3 kiểm tra, 5 đối chiếu trong đào tạo không thay thế việc nhận diện bằng hai thông tin.

- Kiểm tra thuốc: (tên thuốc, nồng độ/hàm lượng, liều dùng một lần, số lần dùng thuốc trong 24 giờ, khoảng cách giữa các lần dùng thuốc, thời điểm dùng thuốc và đường dùng thuốc so với y lệnh). Kiểm tra hạn sử dụng và chất lượng của thuốc bằng cảm quan: màu sắc, mùi, sự nguyên vẹn của viên thuốc, ống hoặc lọ thuốc.

- Cho người bệnh uống hoặc tiêm, truyền thuốc đúng kỹ thuật.

- Thuốc uống qua ống thông hoặc cần nghiền/bẻ: xác nhận dạng bào chế cho phép và hướng dẫn Khoa Dược; không tự nghiền thuốc khi chưa xác nhận. Thuốc tiêm/truyền tuân thủ vô khuẩn và quy trình từng đường dùng.

- Ghi nhận thực hiện sau khi đã dùng thuốc; không đánh dấu hoặc ký xác nhận trước. Nếu chưa dùng, dùng một phần, trễ liều hoặc NB từ chối, ghi rõ lý do và thông báo bác sĩ để quyết định tiếp theo.

- Thực hiện nguyên tắc tiêm an toàn, đảm bảo nguyên tắc vô khuẩn.

5.2.2.3. Sau khi người bệnh dùng thuốc:

- Theo dõi người bệnh:

+ Theo dõi thường xuyên để kịp thời phát hiện các tác dụng không mong muốn và những biểu hiện bất thường của người bệnh. Báo cáo kịp thời cho bác sĩ điều trị, ghi chép đầy đủ các diễn biến lâm sàng của người bệnh vào hồ sơ bệnh án.

+ Bác sĩ điều trị có trách nhiệm theo dõi tác dụng phụ của thuốc và xử lý kịp thời các tai biến do dùng thuốc, ghi sổ theo dõi phản ứng có hại của thuốc.

- Nếu nghi phản vệ, kích hoạt cấp cứu và xử trí theo phác đồ phản vệ đã phê duyệt, trong phạm vi được đào tạo; không chờ hoàn thành báo cáo. Tần suất theo dõi cụ thể theo thuốc, đường dùng và tình trạng NB.

- Hoàn tất ghi nhận trên phiếu/sổ hoặc hệ thống điện tử được phê duyệt: thuốc, liều thực dùng, đường dùng, giờ thực tế, người thực hiện; bổ sung đáp ứng và bất thường. Không chỉ đánh chéo để thay toàn bộ hồ sơ dùng thuốc.

- Xử lý và bảo quản dụng cụ liên quan đến dùng thuốc cho người bệnh theo đúng quy định.

- Vệ sinh xe tiêm, phân loại rác đúng quy định.

5.2.2.4. Quản lý thuốc tại khoa lâm sàng:

- Thuốc trong tủ trực thuốc cấp cứu phải theo đúng danh mục và cơ số đã được phê duyệt và được bảo quản theo đúng quy định và yêu cầu của nhà sản xuất.

- Quản lý thuốc phải kiểm soát đặc biệt theo văn bản hiện hành và quy trình phối hợp Khoa Dược; không dùng quy trình này thay thế hướng dẫn quản lý chuyên biệt.

- Điều dưỡng viên được phân công nhận thuốc: kiểm tra, đối chiếu tên thuốc, nồng độ/hàm lượng, số lượng, chất lượng, dạng bào chế của thuốc trong phiếu lĩnh thuốc khi nhận thuốc từ khoa Dược và khi bàn giao thuốc cho điều dưỡng chăm sóc.

- Khi phát hiện nhầm thuốc hoặc sai liều/đường dùng: ưu tiên đánh giá NB, báo ngay BSĐT hoặc BS trực và gọi hỗ trợ khi cần; đồng thời báo ĐDT và các đầu mối liên quan. Khi mất, hỏng hoặc chênh lệch thuốc, báo ngay người quản lý và Khoa Dược, lập hồ sơ theo quy định.

- Thuốc dư ra do thay đổi y lệnh, do người bệnh chuyển khoa, ra viện, chuyển viện hoặc tử vong (sau đây gọi chung là xuất viện) được tổng hợp trả lại khoa Dược trong vòng 24 giờ. Đối với thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần dư ra phải lập biên bản và trả thuốc theo quy định hiện hành.

- Thực hiện bàn giao số lượng thực tế về thuốc, dụng cụ cho kíp trực sau và ghi Sổ bàn giao thuốc thường trực và Sổ bàn giao dụng cụ thường trực.

- Nghiêm cấm việc cá nhân vay, mượn, đổi thuốc tại khoa lâm sàng./.

VI TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

Bác sĩ: chỉ định đầy đủ, rõ ràng; giải quyết thắc mắc và bất thường của y lệnh; theo dõi điều trị, xử trí tai biến và quyết định tiếp tục, thay đổi hoặc ngừng thuốc.

Điều dưỡng, hộ sinh và nhân viên được phân công: kiểm tra, chuẩn bị, thực hiện và ghi nhận thuốc đúng quy trình; theo dõi NB; báo ngay bất thường và bàn giao các thuốc chưa thực hiện.

Điều dưỡng trưởng: phân công, kiểm tra năng lực và tuân thủ; tổ chức bảo quản, kiểm kê, bàn giao thuốc; phối hợp xử lý sai sót và cải tiến.

Khoa Dược: phối hợp đối chiếu thuốc lĩnh/trả; hướng dẫn bảo quản, tương hợp và sử dụng chế phẩm; quản lý danh mục LASA, nguy cơ cao và kiểm soát đặc biệt theo phân công; tiếp nhận báo cáo ADR qua đầu mối quy định.

Phòng Điều dưỡng và bộ phận QLCL: tổ chức tập huấn, giám sát bằng bảng kiểm, theo dõi khắc phục và báo cáo theo kế hoạch bệnh viện.

VII XỬ TRÍ VÀ BÁO CÁO BẤT THƯỜNG

1. Phát hiện trước dùng thuốc: chưa thực hiện liều có nghi ngờ; xác minh NB, y lệnh và thuốc; báo bác sĩ/dược sĩ để giải quyết. Không tự sửa y lệnh hoặc bỏ qua cảnh báo.

2. Phát hiện trong hoặc sau dùng thuốc: đánh giá ngay ý thức, hô hấp, tuần hoàn và triệu chứng; dừng thao tác sai đang diễn ra, gọi bác sĩ hoặc cấp cứu. Việc tiếp tục/ngừng các thuốc khác do bác sĩ quyết định theo diễn biến.

3. Ghi thời điểm, thuốc, liều, đường dùng, lượng thực nhận, triệu chứng và can thiệp; giữ nhãn/vỏ thuốc và thông tin liên quan phù hợp. Hoàn thành hồ sơ sự cố và/hoặc ADR theo đầu mối bệnh viện; không trì hoãn chăm sóc NB để làm báo cáo.

4. Theo dõi theo chỉ định, bàn giao nguy cơ và kế hoạch; phân tích nguyên nhân, thống nhất khắc phục và đánh giá lại. Cả sự cố được phát hiện trước khi tới NB cũng được ghi nhận theo quy định bệnh viện.

VIII HỒ SƠ VÀ KIỂM SOÁT TÀI LIỆU

Hồ sơ liên quan gồm y lệnh, phiếu công khai thuốc, ghi nhận thực hiện thuốc, phiếu chăm sóc/theo dõi, phiếu lĩnh–trả, sổ kiểm kê và bàn giao, hồ sơ thuốc phải kiểm soát đặc biệt, phiếu ADR/sự cố và bảng kiểm giám sát. Lưu theo quy định quản lý hồ sơ của bệnh viện; không đặt thời hạn lưu mới khi chưa được phê duyệt.

Nơi nhận theo bản nguồn: Ban Giám đốc, Phòng Điều dưỡng, Tổ QLCL, Phòng KHTH, các khoa lâm sàng và Khoa Dược. Chỉ áp dụng bản được ban hành chính thức; cập nhật hoặc thu hồi bản cũ theo hệ thống kiểm soát tài liệu.

Lần sửa / ngày	Nội dung sửa đổi	Người duyệt
Bản trình thẩm định 13/10/2026	Chuẩn hóa nhận diện NB và ghi nhận thuốc; làm rõ xử trí sai sót; cập nhật căn cứ kiểm soát đặc biệt; bổ sung trách nhiệm, hồ sơ và hướng dẫn chấm bảng kiểm.	

PHỤ LỤC BẢNG KIỂM CÔNG TÁC DÙNG THUỐC CHO NGƯỜI BỆNH

Khoa/Bộ phận: ..... Ngày đánh giá: ...../...../.....
Người được đánh giá: ..... Chức danh: ĐD / HS / Khác
Người đánh giá: ..... Ca/đường dùng thuốc: .....

Hướng dẫn chấm: mỗi mục ghi điểm chuẩn khi thực hiện đầy đủ, 0 khi không đạt; mục không áp dụng ghi KAD và nêu lý do. Không chấm điểm một phần nếu chưa có hướng dẫn được duyệt. Tổng điểm chuẩn của 26 mục là 30; điểm tối đa áp dụng bằng 30 trừ điểm chuẩn của các mục KAD. Tỷ lệ = tổng điểm đạt / điểm tối đa áp dụng × 100%. Khi không có đủ bằng chứng hoặc mẫu quan sát, ghi rõ hạn chế và không suy đoán kết quả.

TT	Nội dung đánh giá	Điểm chuẩn	Điểm đạt	KAD / Ghi chú
I	Chuẩn bị phương tiện			
1	Bàn tiêm, khay tiêm sạch, ngăn nắp	1		
2	Có hộp thuốc cấp cứu phản vệ đúng theo quy định khi tiêm thuốc	1		
3	Thuốc, dung môi, bơm kim tiêm…..	0,5		
4	Dung dịch rửa tay, găng tay	1		
5	Thùng rác theo quy định, đảm bảo sạch	0,5		
II	Chuẩn bị người bệnh			
6	Nhận diện đúng NB bằng ít nhất hai thông tin; không dùng số giường/buồng làm định danh.	1		
7	Thông báo việc thực hiện thuốc	1		
8	Kiểm tra tiền sử/thông tin dị ứng trước lần dùng; làm rõ bất thường hoặc dị ứng mới.	2		
III	Khi thực hiện thuốc			
9	Nhân viên nắm quy trình gọi hỗ trợ và xử trí phản vệ trong phạm vi được đào tạo.	2		
10	Đối chiếu nhãn thuốc với y lệnh	1		
11	Kiểm tra lại hạn dùng, chất lượng thuốc	1		
12	Dùng thuốc đúng theo chỉ định của bác sĩ và đúng kỹ thuật	2		

TT	Nội dung đánh giá	Điểm chuẩn	Điểm đạt	KAD / Ghi chú
13	Thực hiện 5 đúng: đúng người bệnh, đúng thuốc, đúng liều lượng, đúng đường dùng, đúng thời gian dùng thuốc	3		
14	Theo dõi đáp ứng và bất thường trong khi dùng thuốc, phù hợp đường dùng và nguy cơ.	1		
IV	Sau khi dùng thuốc			
15	Ghi nhận thuốc đã thực dùng sau thực hiện; không ký/đánh dấu trước.	0,5		
16	Công khai thuốc và hoàn tất xác nhận theo biểu mẫu/quy định đang áp dụng.	1		
17	Thông báo lịch dùng tiếp theo và hướng dẫn NB khi cần; đối chiếu thuốc còn lại phù hợp.	0,5		
18	Theo dõi diễn biến bất thường của người bệnh sau khi uống hoặc tiêm thuốc.	1		
19	Dọn dẹp dụng cụ, phân loại rác đúng quy định	1		
20	Vệ sinh xe tiêm	1		
21	Rửa tay	0,5		
22	Ghi thuốc, liều, đường dùng, giờ thực tế, người thực hiện và đáp ứng/bất thường vào hồ sơ.	0,5		
V	Quản lý thuốc tại khoa			
23	Tủ thuốc trực có đủ thuốc theo danh mục được phê duyệt	2		
24	Tủ thuốc trực đảm bảo thuốc còn hạn dùng	2		
25	Thuốc dôi dư được trả về khoa Dược đúng quy định	1		
26	Có bàn giao thuốc trực hàng ngày và ghi sổ bàn giao đầy đủ	1		
	Tổng cộng	30		

Tổng điểm đạt: ..... Điểm tối đa áp dụng: ..... Tỷ lệ: ..... %
Xếp loại theo ngưỡng bản nguồn: Tốt 95–100%; Khá 80–<95%; Trung bình 60–<80%; Yếu <60%. Cách xử lý KAD và hướng dẫn chấm bổ sung trình bệnh viện phê duyệt trước áp dụng.

Sai sót liên quan nhận diện NB, thuốc/liều/đường dùng hoặc chậm xử trí cấp cứu phải được ghi riêng và khắc phục ngay, dù tổng tỷ lệ cao. Xếp loại giám sát không thay thế việc đánh giá sự cố hay xác nhận năng lực thực hành.

Nhận xét / nội dung cần khắc phục: .....
.....
Người chịu trách nhiệm: ..... Hạn hoàn thành: .....
Kết quả đánh giá lại: .....

Đại diện khoa/bộ phận	Người kiểm tra/giám sát
(Ký, ghi rõ họ tên)	(Ký, ghi rõ họ tên)

Nội dung xác nhận trước ban hành: mã/phiên bản và nhân sự ký; biểu mẫu ghi nhận thuốc; danh mục LASA và nguy cơ cao; quy trình Khoa Dược về thuốc phải kiểm soát đặc biệt; đầu mối ADR/sự cố; cách chấm KAD và tiêu chí giám sát. Các thông số thuốc cụ thể áp dụng theo hướng dẫn chế phẩm và phác đồ bệnh viện.